

《现代医院》作者修改意见（最终提交版）

感谢编辑部和审稿专家的意见。根据“建议将 24 份分析资料列出图表，并扩充资料范围；文章 AI 味过于浓厚，需结合实践进行修改”的意见，作者已对稿件作如下修改：

1. 关于“建议将 24 份分析资料列出图表”：已在第 2 节新增“表 1 纳入分析资料基本情况表”，逐项列示 24 份资料的类型、年份、来源或发布主体、主题及分析用途、纳入理由，并说明该表编号与文末参考文献编号一致。
2. 关于“建议扩充资料范围”：已在资料来源与梳理方法部分补充资料来源、筛选口径和研究边界，将资料范围明确为公开政策法规、内控理论框架、已发表学术文献和可核查国际制度资料；同时说明未公开院内制度文本、个案材料和未能核实的检索结果未纳入分析，避免写入无法复核的材料。相关修改见第 2 节表 1 后文字说明及第 8 节。
3. 关于“文章 AI 味过于浓厚，需结合实践修改”：已对摘要、引言、政策与理论基础、文献矩阵分析、研究空白、管理启示和结论等部分作进一步修改，压缩概括性表述，增加医院科研经费管理中的预算编制、采购合同、经费支出、资产入账、结题结账、成果转化、分级授权、系统校验和留痕追溯等具体场景。同时，对第 4.3 节、第 5 节和第 6 节中较模板化的表述进行重写，取消“共识一/分歧一”等列举式写法，改为结合文献证据和医院业务流程进行说明。相关修改见摘要、第 1 节、第 3 节、第 4 节、第 5 节、第 6 节、第 7 节和第 8 节。
4. 关于图表编号和正文一致性：新增资料表作为表 1，原“全生命周期×COSO 五要素”二维矩阵顺延为表 2，并同步修改正文引用、表题和表注。